



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : كريمه مصطفى فرج شحاته

العنوان : ..

الحي / المدينة : الدقي

المحافظة : الجيزه

تاريخ تسجيل الإستماره : 26-09-2026

رقم البطاقة : 26905250102209 رقم التليفون : 01200118394

العمر (تاريخ الميلاد) : 25-05-1969 المهنة : ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

المقر بما فيه
التوقيع: (-----)

الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/ندى حسن	الوظيفة: -----	التوقيع: -----
الاسم: د/نرمين رمضان	الوظيفة: -----	التوقيع: -----

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
جهة العلاج : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: كريمة مصطفى فرح شحاته National ID: 26905250102209	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بمحافظة الجيزة



كريمة
مصطفى فرج شحاتة
٤٩ ش السودان
الدقي - الجيزة

١٩٩٩/٠٥

٢٦٩.٥٢٥.٠١.٢٢.٠٩

LH5560983

٩١٩٦
٢٣

١٩٠٠١١٨٢٩٤

٠١٠٩٠٤١١٨٥٦



٢٠٢٥/٠٨

٢٦٩.٥٢٥.٠١.٢٢.٠٩

حاصله على دبلوم صنائع

أنسنة

مسلمة

أنثى



البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/٠٨/١١



Patient's Name: Karima Mustafa Farag Shehata
Date: 2026-08-17
Referred by: Prof.Dr. no doctor
Hospital: Goustave Roussey International Egypt



Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 56-year-old female with positive family history (maternal side aunt), complaining of right breast lump of few months duration.

Findings:

Right breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- LOQ middle third & UOQ anterior third two irregular high density mass lesions with surrounding architectural distortion and no suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated two irregular spiculated heterogeneous hypoechoic anti-parallel solid mass lesions with surrounding echogenic grin, posterior acoustic shadowing and mild internal vascularity on color Doppler study seen at:
 - Index lesion: 8 o'clock, 4.5 cm from nipple, 7 mm deep to the skin, measuring 20 x 19 mm.
 - Mass A: 10 o'clock, 3 cm from nipple, 4.3 cm from index measuring 19 x 12 mm, it seen abutting the overlying skin that is seen dimpled.
- Normal nipple/areola complex.
- Single indeterminate axillary LN is noted at level 1 measuring 6.6 x 4 mm with 3.3 focal cortical thickness indenting the hilum.

Left breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 5): Marked Adenosis & outer breast Bi-focal suspicious process as described with ipsilateral indeterminate level 1 axillary lymph nodes.

Left breast (BIRADS 2): Marked adenosis.

Recommendation:-

For CESM, biopsy and histopathological correlation.

Best Regards,
DR. Amal Hegazi, M.Sc.







Patient Name	كريمة مصطفى فرج	Case No.	360616
Sex/Age	Female 57 Y	Patient No.	26353
Registered Date	26/8/2026 09:34:32 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	15/9/2026 01:01:07 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	21/9/2026 09:32:35 AM	Pathology No.	2747/26

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 26/08/2026. Cold ischemia time is 20 seconds.

Gross Examination:

- Three fragmented grey, white tissue cores, ranging in size between 0.3 cm & 1.5 cm long, totally submitted.

Technique:

- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:

- Histologic type: Invasive duct carcinoma
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1)
- DCIS: Absent
- Microcalcification: Present
- Angioinvasion: Absent
- Perineural invasion: Absent
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild

Results:

* IPT (All controls showed appropriate reactivity):

- ER: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 50% of tumor cells (score 7/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 7%.

Conclusion:

Right breast mass, Tru-cut biopsy:

- Invasive duct carcinoma, Grade 2.

IPT:

- ER: Positive (score 8/8).



Patient Name	كريمة مصطفى فرج	Case No.	360616
Sex/Age	Female 57 Y	Patient No.	26353
Registered Date	26/8/2026 09:34:32 AM	Referred By Dr.	Interventional Radiology
Validation Date	15/9/2026 01:01:07 PM	Branch	Gustave Roussy
Reporting Date	21/9/2026 09:32:35 AM	Pathology No.	2747/26

- PR: Positive (score 7/8).

- Her2: Low (score 1+).

- Ki67%: 7%.

**Scoring system: "ER, PR"

ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66% and 10%; 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.

** Scoring system: "Her2"

Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.

IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells.

Signature

Dr. Walaa Ibrahim Ghoneim. MD.



غرفة رقم (4) - الطور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة 2 - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadima - Cairo, Egypt



Patient's Name: Karima Mustafa Farag Shehata

Date: 2026-08-17

Referred by: Prof.Dr. no doctor

Hospital: Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 56-year-old female with positive family history (maternal side aunt), complaining of right breast lump of few months duration.

Findings:

Right breast:

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- LOQ middle third & UOQ anterior third two irregular high density mass lesions with surrounding architectural distortion and no suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated two irregular spiculated heterogeneous hypoechoic anti-parallel solid mass lesions with surrounding echogenic grin, posterior acoustic shadowing and mild internal vascularity on color Doppler study seen at:
 - Index lesion: 8 o'clock, 4.5 cm from nipple, 7 mm deep to the skin, measuring 20 x 19 mm.
 - Mass A: 10 o'clock, 3 cm from nipple, 4.3 cm from index measuring 19 x 12 mm, it seen abutting the overlying skin that is seen dimpled.
- Normal nipple/areola complex.
- Single indeterminate axillary LN is noted at level 1 measuring 6.6 x 4 mm with 3.3 focal cortical thickness indenting the hilum.

Left breast:

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

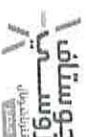
Right breast (BIRADS 5): Marked Adenosis & outer breast Bi-focal suspicious process as described with ipsilateral indeterminate level 1 axillary lymph nodes.

Left breast (BIRADS 2): Marked adenosis.

Recommendation:-

For CESM, biopsy and histopathological correlation.

Best Regards,
DR. Amal Hegazi, M.Sc.



Patient's Name:

Karima Mustafa Farag Shehata

Date:

2026-08-17

Referred by:

Prof.Dr. no doctor

Hospital:

Goustave Roussey International Egypt

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: 56-year-old female with positive family history (maternal side aunt), complaining of right breast lump of few months duration.

Findings:

Right breast:

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- LOQ middle third & UOQ anterior third two irregular high density mass lesions with surrounding architectural distortion and no suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated two irregular spiculated heterogeneous hypoechoic anti-parallel solid mass lesions with surrounding echogenic grin, posterior acoustic shadowing and mild internal vascularity on color Doppler study seen at:
 - Index lesion: 8 o'clock, 4.5 cm from nipple, 7 mm deep to the skin, measuring 20 x 19 mm.
 - Mass A: 10 o'clock, 3 cm from nipple, 4.3 cm from index measuring 19 x 12 mm, it seen abutting the overlying skin that is seen dimpled.
- Normal nipple/areola complex.
- Single indeterminate axillary LN is noted at level 1 measuring 6.6 x 4 mm with 3.3 focal cortical thickness indenting the hilum.

Left breast:

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses asymmetry , distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion:-

Right breast (BIRADS 5): Marked Adenosis & outer breast Bi-focal suspicious process as described with ipsilateral indeterminate level 1 axillary lymph nodes.

Left breast (BIRADS 2): Marked adenosis.

Recommendation:-

For CESM, biopsy and histopathological correlation.

Best Regards,

DR. Amal Hegazi, M.Sc.

269050.1000

Advanced Clinical Exam

الندي الأيسر

كولبرين
1997
سول
الندي الأيمن

طبيعى	تراجع أو تشييد في اتجاه الحلمة
بروز الأوردة	تقرحات بالحلمة أو الحلمة
تغير في الشكل أو الحجم	أفرزات غير طبيعية
حدوث تجويف	الشعور بأورام بالابط
طفح	الشعور بسمك عام
تجاعيد بالحلمة	ألم بالندي
تحويل الجلد لما يشبه قشر البرتقال	ورم محسوس
الإحصار	تم إستئصال الندي

طبيعى	تراجع أو تشييد في اتجاه الحلمة
بروز الأوردة	تقرحات بالحلمة أو الحلمة
تغير في الشكل أو الحجم	أفرزات غير طبيعية
حدوث تجويف	الشعور بأورام بالابط
طفح	الشعور بسمك عام
تجاعيد بالحلمة	ألم بالندي
تحويل الجلد لما يشبه قشر البرتقال	ورم محسوس
الإحصار	تم إستئصال الندي

Maximum mass dimension (mm):

Side:

- o Right
- o Left
- o Bilateral
- o Quadrant:
 - o UOQ
 - o UIQ
 - o LOQ
 - o LIQ
- o Central and retroareolar
- o Axilla

Imaging study requested:

- o Sonography
- o Mammosonography
- o MRI breasts

غير كافى للتسجيل

204

56 year
♀ 1 still single
not married
* 41 -ve

for R + breast mgs
+ Axilla

for Bilateral sonography